



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : صبريه عبد الله عبد الباقي حسن

العنوان : الودى مركز الصف
الجيزة

المحافظة : الجيزة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 19-09-2026

رقم البطاقة : 26004122100506 رقم التليفون : 01120171338

العمر (تاريخ الميلاد) : 12-04-1960 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي
الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودورونيك [14157]
التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان

الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :

التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د. /د. /د. /د. /د. /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :

قسم :
نفقات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: صبريه عبد الله عبد الباقي حسن National ID: 26004122100506	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

صبريه
عبدالله عبدالباقى حسن
قرية الودى
مركز الصف - الجيزة

١٩٦٠/٠٤/١١ ٢٦٠٠٤١٢٢١٠٠٥٠٦

LF2647542

٢٠٢٥/٠٦ ٢٦٠٠٤١٢٢١٠٠٥٠٦

ربة منزل
أنثى

مسلمة

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٢/٠٦/١٨

١



Patient Name : الأستاذة / منيرة عبد الله محمد الباقى
Patient No. : 26004122100506
Path No. : 3763/24
Sex : Female
Age : 64 Y
Referring Doc :

Request No. : 13005686
Request Date : 03/10/2024
Verification Date : 16/10/2024
Financial Category : وزارة دار السلام - نفقة الدولة
Department : Out Patient
IHC No. :
Registered by : marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Right breast suspicious mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 02/10/2024.

Technique:

- Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against:
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Results:

- IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 7% of tumor cells (score 5/8).
- PR: Faint nuclear reaction in 40% of tumor cells (score 5/8).
- Her2: No membrane reaction in tumor cells (score 0).
- Ki67: 10% nuclear reaction of tumor cells.

Conclusion:

Right breast suspicious mass, tru-cut biopsy:

invasive duct carcinoma, Grade II, with focal high grade DCIS comedo pattern, and microcalcification
PT:

- ER: Positive (score 5/8).
- PR: Positive (score 5/8).
- Her2: Negative (Score 0).
- Ki67: Positive in 10% of tumor cells.

Scoring system: *ER, PR*

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations, 2010 Allred score: proportion of cells staining (0)

Verified by:

Dr.Toka Medhat

Printing Date : 20/10/2024 15:21:08

Page 1 of 2

Printed By : marwa mohamed yousse



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (587) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mir El Qadima - Cairo, Egypt

Patient Name: Sabriah Abd Allah Abd Al Baky	Date : 03/03/2025
Exam : DUPPLEX VIENS BOTH LEGS	Age : 65 Year(s)
Medical ID: 368/2024	Pat ID: 93752

Duplex Examination of the venous systems of both lower limbs revealed: -

Deep Venous System: -

- > The femoral (common & superficial), popliteal & infrapopliteal veins of the examined lower limb all are Patent, totally compressible with normal color filling & preserved respiratory variation.
- > No evidence of D.V.T at time of scan.

Superficial Venous System: -

- > Patent long & short saphenous veins with no evidence of superficial thrombophlebitis at time of scan.

OPINION: -

No evidence of acute D.V.T or superficial thrombophlebitis at time of scan
Mild interstitial edema of the examined limb

Signature Dr. Nermien Ramadan
PM 1:37 2025/03/03



Patient Name: Sabriah Abd Allah Abd Al Baky	Date : 17/11/2024
Exam : MRI CERVICAL SPINE	Age : 64 Year(s)
Medical ID: 3684/2024	Pat. ID: 93752

MRI OF THE CERVICAL SPINE

MRI TECHNIQUE:

- Sagittal T1 and T2 WI
 - Axial T2 WI
- (plates 1 & 2).
(plate 3).

MRI FINDINGS:

- Normal dimensions of the cervical spinal canal.
- Cervical spondylosis manifested by marginal osteophytic lipping of the vertebral endplates and reduced T2 signal of the intervertebral discs denoting their degeneration.
- C3/4 central and left para central posterior disc protrusion seen effacing the ventral CSF space, indenting the cord and encroaching upon the left neural exit pathway.
- C4/5, C5/6 and C6/7 small central posterior disc protrusions seen effacing the ventral CSF space and slightly indenting the cord at C4/5 level.
- C3/4 left and C5/6 bilateral neurocentral joint arthropathy.
- Normal size and signal intensity of the cervical spinal cord.
- Normal cranio-cervical articulations.
- No marrow infiltrative lesions.
- No paraspinal soft tissue lesions.

OPINION:

- Cervical spondylosis with multilevel disc lesions as described.

MRI OF THE DORSAL SPINE

MRI TECHNIQUE:

- Sagittal T1 and T2 WI
 - Axial T2 WI
- (plates 1 & 2).
(plate 3).

MRI FINDINGS:

- Normal dimensions of the dorsal spinal canal.
- Dorsal spondylosis manifested by marginal osteophytic lipping of the vertebral endplates and reduced T2 signal of the intervertebral discs denoting their degeneration.



Patient Name: Sabriah Abd Allah Abd Al Baky	Date : 17/11/2024
Exam : MRI CERVICAL SPINE	Age : 64 Year(s)
Medical ID: 3684/2024	Pat. ID: 93752

- D11/12 annular relaxation.
- Normal size and signal intensity of the dorsal spinal cord.
- No marrow infiltrative lesions.
- No abnormal paraspinal soft tissue lesions.

OPINION:

- Dorsal spondylosis.
- D11/12 annular relaxation.

MRI OF THE LUMBOSACRAL SPINE

MRI TECHNIQUE:

- Sagittal T1 and T2 WI
- Axial T2 WI

(plates 1 & 2).
(plate 3).

MRI FINDINGS:

- Lumbar spondylosis manifested by marginal osteophytic lipping & degenerative marrow changes of the vertebral endplates and reduced T2 signal of the intervertebral discs denoting their degeneration.
- L1/2 down to L4/5 diffuse postero-bilateral disc bulges seen effacing the ventral epidural space, indenting the theca and encroaching upon the neural exit pathways.
- L5/S1 small posterior and right posterolateral disc protrusion seen effacing the ventral epidural space, indenting the theca and encroaching upon the neural exit pathways, more at the right.
- Multilevel hypertrophied ligamenta flava adding to spinal canal tightness.
- Normal size and signal intensity of the conus medullaris.
- No marrow infiltrative lesions.
- No paraspinal soft tissue masses.

OPINION:

- Lumbar spondylosis multilevel degenerative disc lesions as described.

Dr. Ali Elsisy, MSc.

Dr. Walid Mohamed, M.D.

M.R.I.
[[DOCTYPE:MRI]]



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A- Patient ID:

1- Name: منيرة عبد الله عبد الجبار حسن

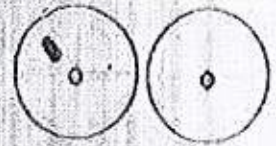
Sex:

3- Medical numbers:
Female83239234
Old MedDate of birth
1681-2024

2- ID number:

Patient Age: 65 Y

MDT



Family history

Family history
-ve

Phone

Phone

01120171338

BMI

BMI

REASON OF MDT

Reason of MDT
BC + L

Marital status

Marital status
Married

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP

Date of MDT

Date of MDT

Comorbidity

Comorbidity
AsymptomaticMenopausal
statusMenopausal status
Postmenopausal

Initial stage

Initial stage

12/12/2024

Clinical data

Last Imaging:

- UOQ mass 40x13 mm 5 cm from nipple
- ded intraductal extension 2 cm from the nipple
- ded non specific axillary LN one seen at level thickened
- 1 mm, another subcentimetric LN are noted with muffled

Mets Workup:

- cap with contrast: pulmonary nodules
- osteopenia & multiple lucent foci at multi vertebral sternum

BCX IHC	ER 5/8	PR 5/8	Her 2 Neu 0	SISH	KI67 10
BCX with focal des high grade + microcalcification	ER 5/8	PR 5/8	Her 2 Neu 0	SISH	KI67 10

1	N	M
2	1	0

Sonomammography

PATIENT HISTORY

bilateral breast SM: rt breast UOQ malignant lesion 2.6x1.3 cm BIRADS 5+pathological axillary LN
pt on tam
MRI SPINE DEGENERATIVE CHANGES

MDT OUTCOME & PLAN

ECR RT BCS AND AXILLA ACC TO TARGET US

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

MEDICAL ONCOLOGY
Signature

RADIOLOGY

SURGERY

SURGERY
Signature

PATHOLOGY

Psychiatric

Psychiatric
Signature

Nutrition



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الاست المصرية
صحة
مصر

MDT FORM 27/12/2023 G

Name	مروة عبد الله عبد الله	MRN	2712 / 2
Age	64 Yrs.	ID	12529545
Menopausal status	Post	Phone	0120171338
NRS SCORE		Marital status	W. 10779994
BMI		Family history	-ve
CO morbidity	M → S →	REASON OF MDT	Post-op

Clinical Data

BX: PT underwent Rt BCS + ALM (R)			
ER:	PR:	HER 2:	Ki67:
Sonomammography: TDC GIII			
Mets Workup: Fria margins → 0.1 cm margins L.Ns (7/11) Focal DTS			



TNM

Stage PT2.PN2

Recommendations:

MDT OUTCOME & PLAN

For:
① adjuvant Taxol[®] 1 AC x 4
② PORT
③ AI x 5 years (consider extended)

SIGNATURE

HT

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric